



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA PONEK
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
MARET 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA PONEK BULAN MARET 2026
RS PRIMA HUSADA MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN) masih menjadi tantangan besar, di mana banyak kematian tersebut disebabkan oleh komplikasi obstetri dan neonatal yang sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan yang cepat dan tepat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, penyebab utama kematian ibu antara lain perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, serta komplikasi persalinan, sementara kematian neonatal sering terjadi akibat asfiksia, infeksi, dan bayi berat lahir rendah (BBLR).

Untuk menurunkan AKI dan AKN, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengembangkan Layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) sebagai upaya memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal. PONEK merupakan layanan terpadu di rumah sakit yang menyediakan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal 24 jam dengan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas memadai, serta standar prosedur yang jelas. Implementasi layanan PONEK secara optimal diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan juga berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan maternal-neonatal di Indonesia dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Demi terselenggaranya keberhasilan PONEK diperlukan dukungan berbagai aspek krusial yang saling terkait, mulai dari penyediaan sumber daya manusia hingga penguatan sistem rujukan.

Pertama, rumah sakit menyiapkan tim medis khusus yang terdiri dari dokter spesialis obstetri-ginekologi, dokter anak, dokter anestesi, dan tenaga bedah, perawat dan bidan yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Kompetensi tim ini terus dijaga melalui program pelatihan berkala dan simulasi kasus gawat darurat. Infrastruktur menjadi pilar penting lainnya. Rumah sakit menyediakan ruang PONEK yang beroperasi 24 jam, dilengkapi dengan ruang bersalin, ruang operasi cesar, serta ruang perawatan intensif untuk ibu (PICU) dan bayi baru lahir (NICU). Kelengkapan alat medis, Laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan cepat dan bank darah yang siap pakai turut mendukung kesiapan penanganan kasus emergensi. Sistem rujukan yang efektif dibangun melalui kerja sama erat dengan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan klinik.

Protokol klinis yang jelas menjadi panduan tim medis dalam menangani berbagai komplikasi. Rumah sakit menyusun standar operasional prosedur untuk menangani perdarahan, eklampsia, sepsis, dan distosia persalinan, termasuk alur cepat untuk pasien kritis. Audit maternal-perinatal secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan administratif dan pendanaan menjadi tulang punggung operasional PONEK. Rumah sakit mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan SDM, pemeliharaan alat, dan penyediaan obat-obatan emergensi.

Laporan bulanan ponek dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran pelayanan PONEK yang ada di RS Prima Husada Malang.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit*
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan serta mengutamakan keselamatan pasien.

1.3.2 Tujuan

1. Memberikan informasi pelayanan PONEK
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan PONEK
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan pasien dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 Motto

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adii
7. Peduli

2.5 SOTK



STRUKTUR ORGANISASI TIM PONEK
RS PRIMA HUSADA MALANG

KETUA TIM PONEK
dr. Aida Musyarofah Sp.OG



Analiasa	- Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda. - Program rotasi: Program rotasi tim PONEK berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim PONEK dan bila ada anggota yang resign. Pada bulan Maret 2026 tidak ada pergantian anggota Tim PONEK
Rencana Tindak lanjut	Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan inhouse training dan Drill Emergency terkait kegawat daruratan maternal Neonatal.

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Pola Ketenagaan

3.1.1 Jumlah SDM

Tabel 3.1.1 Jumlah SDM Tim Ponek RSPHM bulan Maret 2026

Jabatan	Jumlah SDM				Ket.
	Standar	Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026	
Ketua Tim Ponek	1	1	1	1	
Sekretaris Tim Ponek	1	1	1	1	
Anggota Tim Ponek	11	11	11	11	

3.1.2 Pemenuhan kualifikasi SDM

Tabel 3.1.2 Kualifikasi SDM RSPHM Tim Ponek RSPH Maret 2026

Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi		Keterangan
	Standar	Ponek (Wajib)	PPGDON (Wajib)	
Ketua Tim Ponek : dr. Aida Musyarofah Sp.OG	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
Sekretaris Tim Ponek : Siti Zaimah Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
1. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
2. dr. Dicky, Sp.A M biomed	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
3. dr. Isrotul Annisa	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Dokter IGD
4. dr. Annishafira	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Dokter IGD
5. Triasih, Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
6. Elok Oktviana Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	
7. Rismaya Felantriardianti S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat Neonatologi
8. Leny Puji Rahayu Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Bidan Poli
9. Dwinta Widya Navita,Amd.Kep	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat ICU
10. Anita Sari S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Perawat IKO
11. Nining Tri Sari,Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	

Analiasa	- Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda. - Program rotasi:
----------	---

	Program rotasi tim PONEK berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim PONEK dan bila ada anggota yang resign. Pada bulan Maret tidak ada pergantian anggota Tim PONEK • 6 anggota tidak melakukan Diklat PPGDON dikarenakan 2 orang dokter IGD, 1 orang perawat Neonatologi, 1 orang perawat ICU, 1 orang perawat IKO saat belum perlu melakukan diklat PPGDON
Rencana Tindak lanjut	• Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan inhouse training dan Drill Emergency terkait kegawat daruratan maternal Neonatal untuk unit Maternitas, Neonatologi, IGD, ICU,IKO • Pengajuan Diklat PPGDON ke SDM tahun 2026 2 orang

3.1.3 Pelaksanaan Orientasi Khusus di Unit bagi Karyawan baru Ponek RSPH Malang bulan Maret 2026

Tabel 3.1.3. Pelaksanaan Orientasi Khusus di Unit bagi Karyawan baru Ponek RSPH Malang bulan Maret 2026

No	Nama Peserta	Tanggal Masuk	Pembelajaran Yang diterima	Hasil Evaluasi orientasi KHUSUS PONEK								
				Pengetahuan regulasi	Praktek keterampilan	7 nilai budi utama/						
						J	T	V	D	K	A	P
	-											

3.1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Maret 2026

Tabel 1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Maret 2026

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelak sanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak Hadir		
	-					

3.2. Fasilitas PONEK
Tabel 3.2. Fasilitas Ponek RSPHM bulan Maret 2026

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	USG Transport	Ruang tindakan	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
2	USG 4D	Poli kandungan	1	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 4/09/2025

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
3	IUD SET	Poli kandungan Ruang tindakan	2 set 2 set	Baik Siap Pakai	
4	Inkubator	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
5	Cuvis	Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	
6	Monitor ECG	Ruang tindakan	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 2/9/2025
7	Box bayi	Perinatologi	15 unit	Baik Siap Pakai	
8	Fototerapi	Perinatologi	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
9	Suction bayi	Ruang tindakan/ IKO	1 set 1 set	Baik Siap Pakai	
10	Partus Set	Ruang tindakan	7 set	Baik Siap Pakai	
11	Curetage set	Ruang tindakan	4 set	Baik Siap Pakai	
12	Vacum manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
13	Timbangan bayi	Ruang tindakan, NICU, PONEK	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
14	NST/CTG	Ruang tindakan, PONEK	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/9/2025
15	Dopler	Ruang tindakan IGD Ponek	2 unit 1 Unit	2 unit baik 1 Unit	Kalibrasi 8/09/2025
16	Infarm warmer	Ruang tindakan. IKO IGD ponek	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 3/9/2025
17	Forsep	IKO	1 set	Baik Siap Pakai	
18	C-PAP Mesin	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
19	Vakum set manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
20	AmbuBag Bayi	Ruang tindakan	3 set	Baik Siap Pakai	
21	Ambubag Dewasa	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
22	Larigoskop bayi dan anak	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
23	Oxymetri neonates	Ruang perinatologi	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
24	Pulse oksimetri neonates baru	Ruang Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
25	Sendok kuret makro no 8 dan 10	Ruang Tindakan	2 unit	Baik siap pakai	
26	Micro curret	Ruang Tindakan	1 unit	Baik siap pakai	

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
27	Sendok Curret	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
28	HPP set	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
29	Busi kecil	Ruang Tindakan	2 set	Baik siap pakai	
30	Busi besar	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
31	Spekulum besar	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
32	Spekulum sedang	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
33	Spekulum kecil	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
34	Nalfuder No 20	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik Siap pakai	
35	Inkubator transport	Ruang Perinatologi	1 Unit	Baik Siap pakai	Kalibrasi 8/09/2025

Analisis :

- 1) Secara umum kondisi fasilitas dan peralatan PONEK cukup lengkap, Khusus alat penunjang medis yang elektrik sudah terkalibrasi
- 2) Bulan Februari tidak ada penambahan alat
- 3) Bulan februari ada alat CPAP Stephan/ CPAP Easy Plus dilakukan perbaikan karena alat berbunyi terus
- 4) Jadwal kalibrasi rencana bulan September 2026

Rencana Tindak lanjut :

- 1) Melakukan pengecekan alat setiap 1 bulan sekali oleh PJ alat di supervise oleh karu
- 2) Melakukan pemeliharaan alat secara berkala setiap 1 bulan sekali oleh IPSRS
- 3) Melakukan kalibrasi setiap 1 tahun sekali yang rencana akan dilakukan pada bulan September 2026

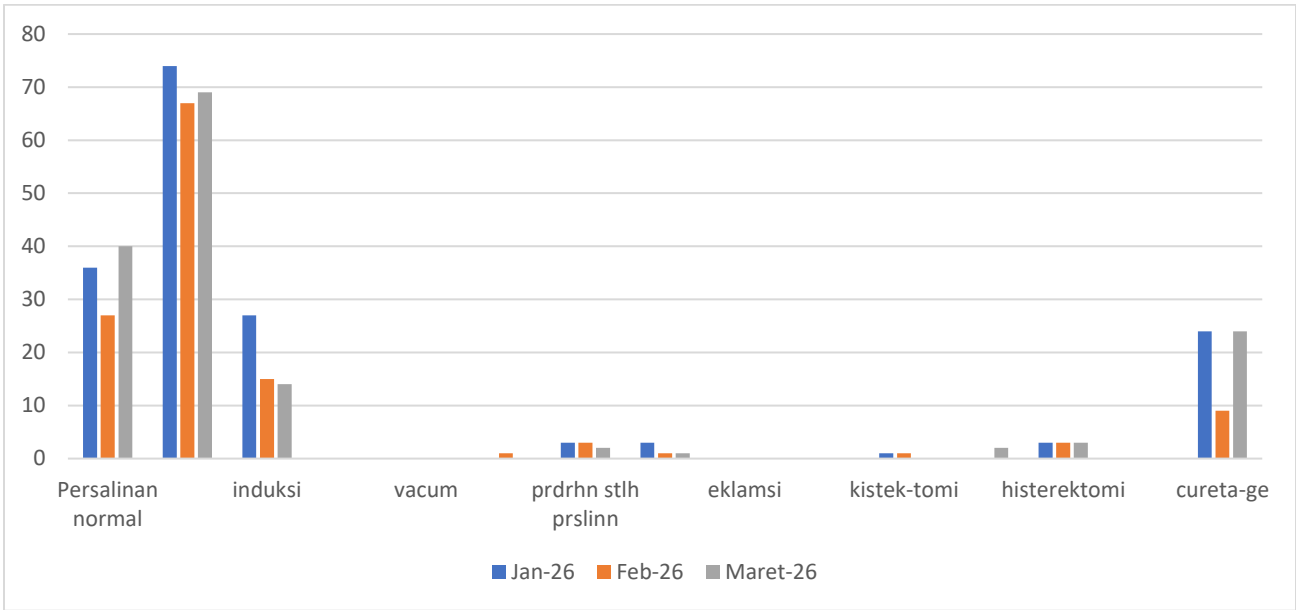
3.3 Kinerja Produktivitas

3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal
Tabel 3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek RSPHM Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	36	27	40
	b. <i>SectioCaesaria</i>	74	67	69
2				
	a. Induksi / Drip	27	15	14
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	1	0

	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	3	2
	c. Pre Eklamsi	3	1	1
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	0	0	0
4				
	a. Curretage	24	9	24
	b. Kistektomi	1	1	0
	c. Miomektomi	0	0	2
	d. Histerectomy	3	3	3
	e. KET	0	0	0

Grafik 3.3.1
 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis:

- 1) Pada jenis persalinan normal pada bulan Maret 2026 yaitu 40 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 27 pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 36 pasien.
- 2) Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Maret 2026 yaitu 69 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 67 pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 74 pasien.
- 3) Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya,CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.
- 4) Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
- 5) Induksi/Drip pada bulan Maret 2026 yaitu 14 pasien, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 15 pasien, sedangkan bulan januari yaitu

- 27 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.
- 6) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Maret 2026 yaitu 1, menurun dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 1, sedangkan bulan januari 2026 yaitu 3 pasien
 - 7) Jenis pelayanan curretage di bulan Maret 2026 yaitu 24 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 9 pasien, sedangkan bulan januari 2026 yaitu 24 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

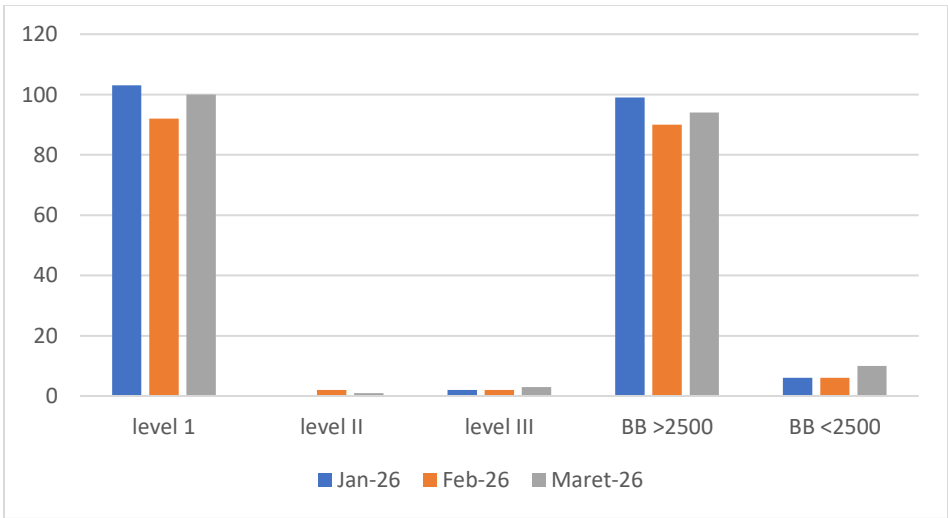
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

3.3.2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal
Tabel 3.3.2 tabel jumlah kegiatan pelayanan neonatal Ponpek RSPHM Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1				
	a. Level 1/ rawat gabung	103	92	100
	b. Level II/ rujukan dari luar	0	2	1
	c. Level III/NICU	2	2	3
2				
	a. BB ≥ 2500 gram	99	90	94
	b. BB ≤ 2500 gram	6	6	10

Grafik 3.3.2
Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1) Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan Maret 2026 yaitu 100 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 92 pasien, sedangkan januari yaitu 103 pasien
- 2) Pada pelayanan level 2/ rujukan dari luar pada bulan Maret 2026 yaitu 1 pasien , menurun dibandingkan bulan Februari yaitu 2 pasien, sedangkan pada bulan januari yaitu 0 pasien.
- 3) Pada pelayanan level 3 pada bulan Maret yaitu 3 pasien, menurun dibandingkan dengan Februari dan Januari yaitu 2 pasien.
- 4) Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan Maret 2026 yaitu 94 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 90 pasien pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 99 pasien.
- 5) Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Maret 2026 yaitu 10 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari dan Januari 2026 yaitu 6 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3) Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.3.3 Jumlah Kelahiran Mati Neonatal

Tabel 3.3.3 Jumlah Kelahiran Mati Neonatal RSPHM Bulan Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026
1	Kelahiran Mati /IUFD	1	0	1
2	Mati Neonatal < 7 Hari yang partus di PHM	0	0	1
3	Mati Neonatal < 7 Hari yang rujukan dari luar	0	0	0

Analisis:

- 1) Bulan Maret 2026 ada 1 kasus kelahiran mati/IUFD, pada Februari 2026 tidak ada, sedangkan bulan Januari terdapat 1 pasien.
- 2) Bulan Maret ada 1 kasus kematian neonatus <7 hari yang lahir di RS, sedangkan bulan Februari dan januari tidak ada. Ini disebabkan bayi lahir BBLSR dengan kelainan anenche pali.
- 3) Pada 3 bulan terakhir Maret, Februari dan Januari 2026 tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari yang bayi rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

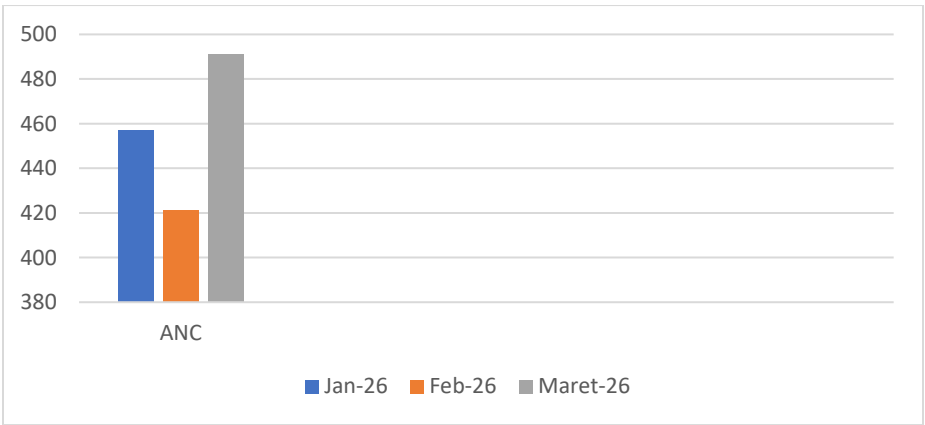
- 1) Melakukan Notifikasi di aplikasi MPDN segera 1 x 24 jam untuk semua kematian.
- 2) Melengkapi RMP (Rekam Medis Perinatal) di aplikasi MPDN kurang dari 7 hari untuk bayi IUFD UK > 28 minggu,dan kelahiran bayi mati sampai usia 28 hari
- 3) Melakukan audit maternal neonatal internal RS

3.3.4 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel 3.3.4 Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek RSPHM Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	ANC	457	421	491

Grafik 3.3.4
Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis

- 1. Pelayanan ANC pada bulan Maret 2026 yaitu 491 pasien mengalami peningkatan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan 2 bulan sebelumnya, Sedangkan pada bulan Februari yaitu 421 pasien, dan bulan januari yaitu 457 pasien
- 2. Faktor Sistem dan Kebijakan terkait perubahan regulasi JKN

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn
- 2) Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
- 3) Melakukan Program kelas ibu hamil

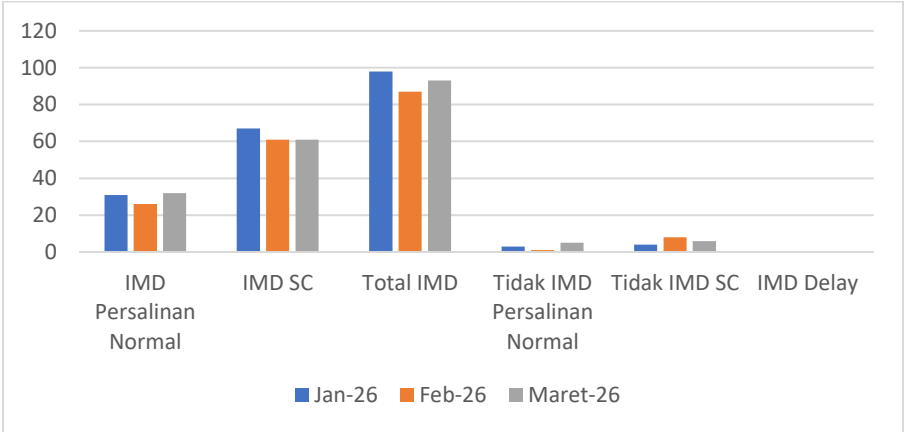
3.3.5 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel 3.3.5 Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Maret 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	IMD Persalinan Normal	31	26	32

2	IMD SC	67	61	61
3	Total IMD	98	87	93
4	Tidak IMD Persalinan Normal	3	1	5
5	Tidak IMD SC	4	8	6
6	IMD Delay	0	0	0
	Total Persalinan Normal	36	27	37
	Total Kelahiran SC	74	67	67
	Total kelahiran	110	94	104

Grafik 3.3.5
Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1) Pada bulan Maret 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 32 pasien,meningkat di bandingkan bulan Februari yaitu 26 pasien sedangkan bulan Januari yaitu 31 pasien Bayi.
- 2) Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan Maret yaitu 61 pasien, sama dengan bulan Februari, sedangkan bulan Januari yaitu 67 pasien Bayi.
- 3) Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan Maret yaitu 5 pasien, meningkat dibandingkan bulan Februari yaitu 1 pasien sedangkan bulan januari yaitu 3 pasien.
- 4) Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan Maret 2026 yaitu 6 pasien, menurun dibandingkan bulan Februari yaitu 8 pasien, sedangkan bulan januari yaitu 3 pasien,
- 5) Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 6) Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Maret 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
1	By Ny Zulia	NCB + BBLR	Infant warmer
2	By Ny Dayinta	BBLSR + Anenchepali	Cuvis
3	By Ny Putri Riskia	NCB + BBLR	Infant warmer
4	By Ny Alfiyah	NKB + BBLR	Infant warmer
5	By Ny Nur Habibahtur	NKB + BBLR	Infant warmer
SC			
1	By Ny Mella 1	NKB + BBLR + gemeli	Cuvis
2	By Ny Mella 2	NKB + BBLR + gemeli	Cuvis

3	By Ny Raquela	NKB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Maulidia	NKB + BBLR + RDS	Inkubator, CPEP
5	By Ny Bella	NCB + BBLR	Infant warmer
6	By Ny Ila Nur Janah	NCB + ibu Hepatitis B	Infant warmer

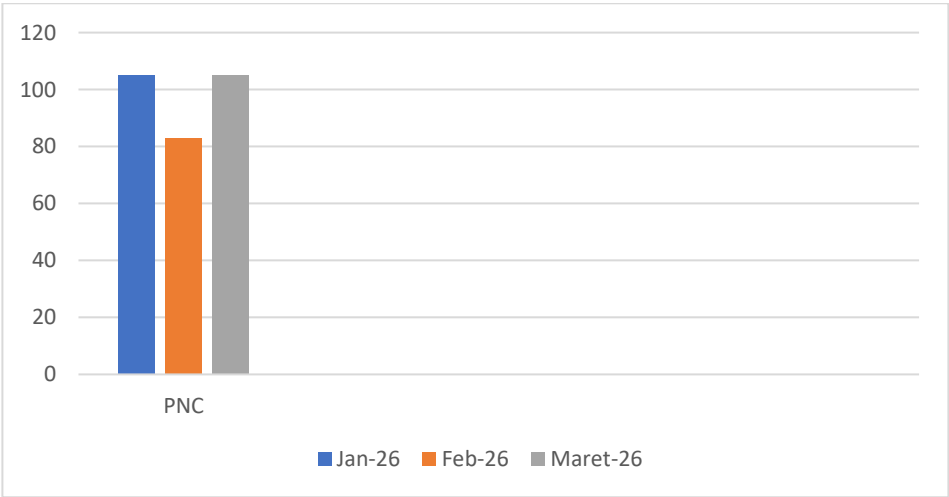
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Skin-to-Skin Contact setelah stabil, dilakukan di ruang NICU/Perinatologi jika memungkinkan.
- 2) Early Initiation of Expressed Breast Milk (EBM), Ibu dipandu memerah ASI dalam 1–2 jam pertama dan ASI diberikan melalui metode sesuai kondisi bayi
- 3) Metode Kangaroo Mother Care (KMC) untuk bayi BBLR stabil.

3.3.6 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel 3.3.6 Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek RSPHM Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	PNC	105	83	105

Grafik 3.3.6
Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis:
 Pelayanan PNC pada bulan Maret 2026 yaitu 105 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu 83 pasien, sedangkan bulan Januari sama, yaitu 105 pasien.

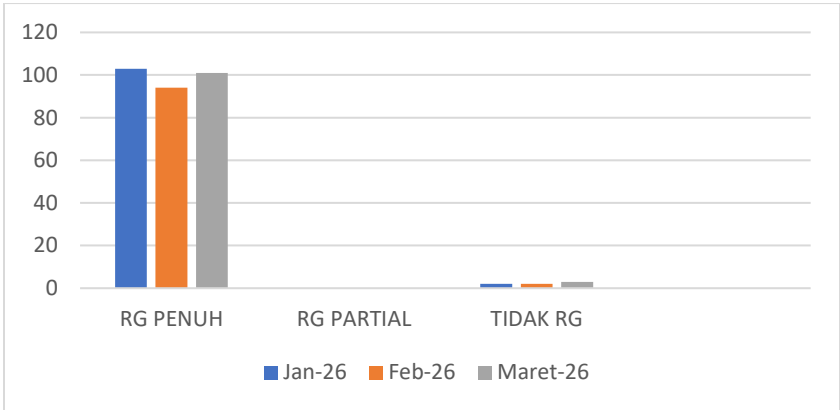
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas (KF1: 6–48 jam, KF2: 3–7 hari, KF3: 8–28 hari, KF4: 29–42 hari)
- 2) Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
- 3) Melakukan eduaksi pentingnya KB pasca salin

3.3.7 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel 3.3.7 Pelayanan Rawat Gabung Ponpek RSPHM Maret 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Rawat gabung penuh	103	94	101
2	Rawat gabung partial	0	0	0
3	Tidak Rawat gabung	2	2	3

Grafik 3.3.7
Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1) Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2026 yaitu 101 bayi meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yaitu 94 pasien, sedangkan bulan Januari yaitu 103 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2026 yaitu 3 bayi, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari dan Januari 2026 yaitu 2 bayi.
- 3) Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Dayinta	BBLSR + Anenchepali	cuvis
2	By Ny Maulidia	NKB + BBLR + RDS	Inkubator, CPEP
3	By Ny Vebby	RDS	Inkubator, CPEP

- 4) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

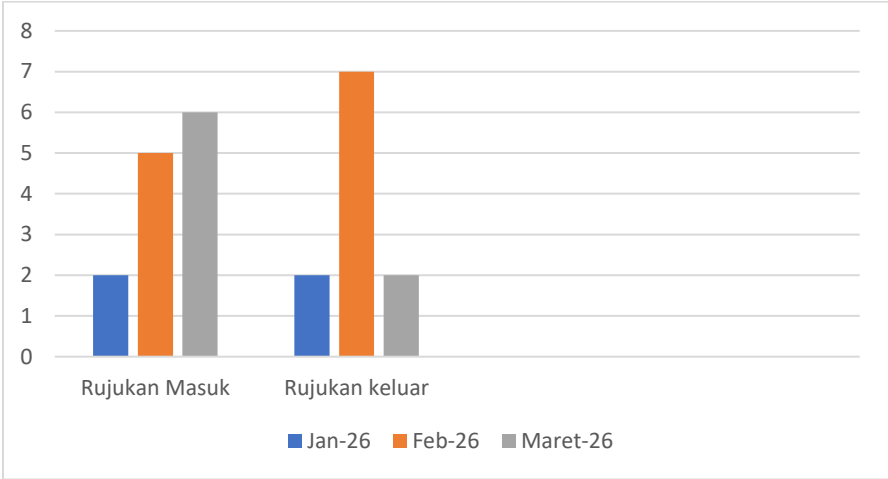
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- 2) Fasilitasi ibu untuk pemerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- 3) Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- 4) Pelaksanaan Kangaroo Mother Care pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.3.8 Pelayanan Rujukan
Tabel 3.3.8 Pelayanan Rujukan Ponek RSPHM Maret 2026

No	Rujukan	Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Rujukan Masuk	2	5	6
2	Rujukan keluar	2	7	2

Grafik 3.3.8
Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Maret 2026



Evaluasi :

- 1) Jumlah rujukan masuk pada bulan Maret 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang lalu, yaitu 6 rujukan, sedangkan pada bulan Februari 2026 sebanyak 5 rujukan, dan bulan Januari sebanyak 2 rujukan.
- 2) Jumlah rujukan keluar pada bulan Maret 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 rujukan, sedangkan pada bulan Februari 2025 sebanyak 7 rujukan, dan Januari sebanyak 2 rujukan keluar.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
- 2) Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.3.8.1 Rujukan Masuk
Tabel 3.3.8.1 Rujukan Masuk Ponek RSPHM Maret 2026

Bulan Januari 2026			
1	Ny Maddinatul Nor	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD	PMB Lilik
2	Ny Sinta	G2 P0000 Ab100 UK 39-40 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
Bulan Januari 2026			
1	By Ny Febriyanti	RDS	RS Enggal Dangan

2	Ny Riya Uliyana	G4 P2002 Ab001 UK 38-39 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Fitriyah Nur F	Ruptur perineum grade 3	PKM Singosari
4	Ny Angely Reza	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan kala 2	PKM Ardimulyo
5	Ny Bella Sari	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 minggu dengan kala 2 lama	PKM Ardimulyo
Bulan Februari 2026			
1	Ny Wiwik Puji A	G5 P2002 Ab200 UK 39-40 minggu dengan KPD + letak Obliq	PMB Munawaroh
2	Ny Heny S	Anemia + AUB	Dr.Rifatul
3	Ny Rika S	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Irma S	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KPD + susp CPD	PMB Titik S
5	Ny Lelly Priga	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD	PMB Titik S
6	Ny Cello velinda	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD + HT gestasional+ letak Obliq	PMB Lilik A

3.3.8.2 Rujukan Keluar
Tabel 3.3.8.2 Rujukan Keluar Ponек RSPHM Maret 2026

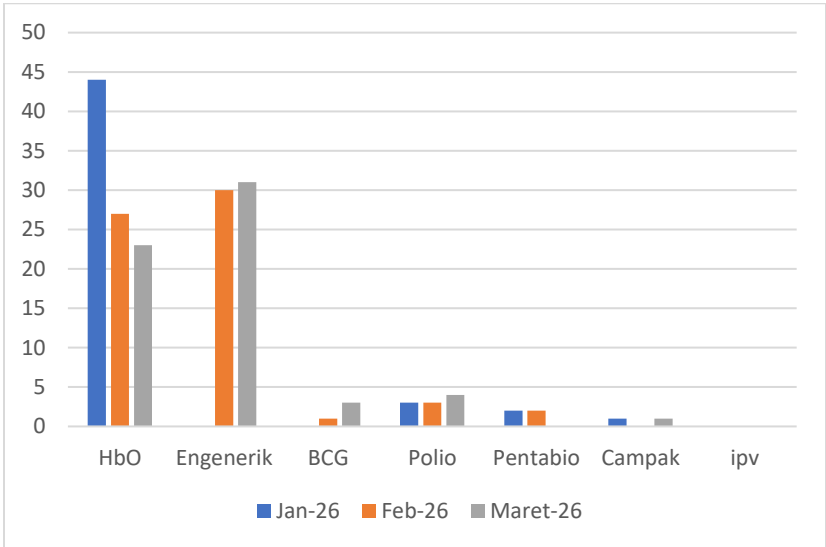
No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan Januari 2026						
1	BY Ny Hazizah	1 hari	NICU	RDS, BBLR, Pneumonia, NKB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
2	Ny Rizki Mega	33 tahun	Maternitas	P0201 Ab100 dengan post partum VBAC + post histerektomi atas indikasi HPP + susp policitimiavera	Penangan Lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan Februari 2026						
1	By Ny Mewah	1 hari	NICU	RDS+Neonatal bronchopneumonia + NEC	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
2	By Ny Nuriana	1 hari	NICU	NCB+ Multiple Congenital + susp PJB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
3	By Ny Yeyen	1 hari	NICU	Atresia ani tanpa fistel + undensensus testis + susp DS	Pro bedah anak	RS Saiful Anwar
4	Ny Rizki Ika	32 tahun	Maternitas	G3 P2002 Ab000 UK 32-34 minggu dengan PPI	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
5	Ny Dyah Ayuning	26 tahun	Ponек	G1 P0000 Ab000 UK 26-28 minggu dengan Ppi + APB EC PLR	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
6	NY Ivatul Khoiria	40 tahun	Ponек	G4 P1001 AB200 UK 28-30 minggu dengan BSC + KPD preterm	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
7	Ny Vita Afifatul	27 tahun	Maternitas	G3 P2002 Ab000 UK 37-38 minggu dengan	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar

				Letak lintang + BSC 2x + B20		
Bulan Maret 2026						
1	By Ny Savira	1 hari	NICU	RDS ok Neonatal pneumonia dd MAS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
2	NY Aisyah Kayla	30 th	Ponek	G1 P0000 Ab000 Uk 32-34 minggu dengan PEB	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar

3.4 Pelayanan Imunisasi
 Tabel 3.4.1 Pelayanan Imunisasi Ponek RSPHM Maret 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Februari 2026
1	HbO	44	27	23
2	Engerix Junior	0	30	31
3	BCG	0	1	3
3	Polio	3	3	4
4	Pentabio	2	2	0
5	Campak	1	0	1
6	IPV	0	0	0

Grafik 3.4.1
 Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis

- 1) Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Maret 2026 yaitu 23 pasien, menurun jika dibandingkan dengan bulan Februari yaitu sebanyak 27 bayi, sedangkan pada bulan Januari sebanyak 44 bayi, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum

- 2) Pada bulan Maret ada 31 bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, meningkat dibandingkan Februari yaitu 30 bayi, sedangkan bulan Januari belum ada vaksin Engerix Junior hal ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
- 3) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
- 4) Ada 3 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Maret 2026 dan meningkat dibandingkan dengan Februari yaitu 1 bayi, sedangkan bulan Januari 0.
- 5) Ada 1 bayi yang Imunisasi Campak bulan Maret dan Januari 2026, di bulan Februari tidak ada.
- 6) Ada 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Maret 2026, sedangkan 2 bulan sebelumnya sebanyak 3 bayi.
- 7) Tidak Ada bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Maret 2026, sedangkan pada 2 bulan sebelumnya ada 2 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

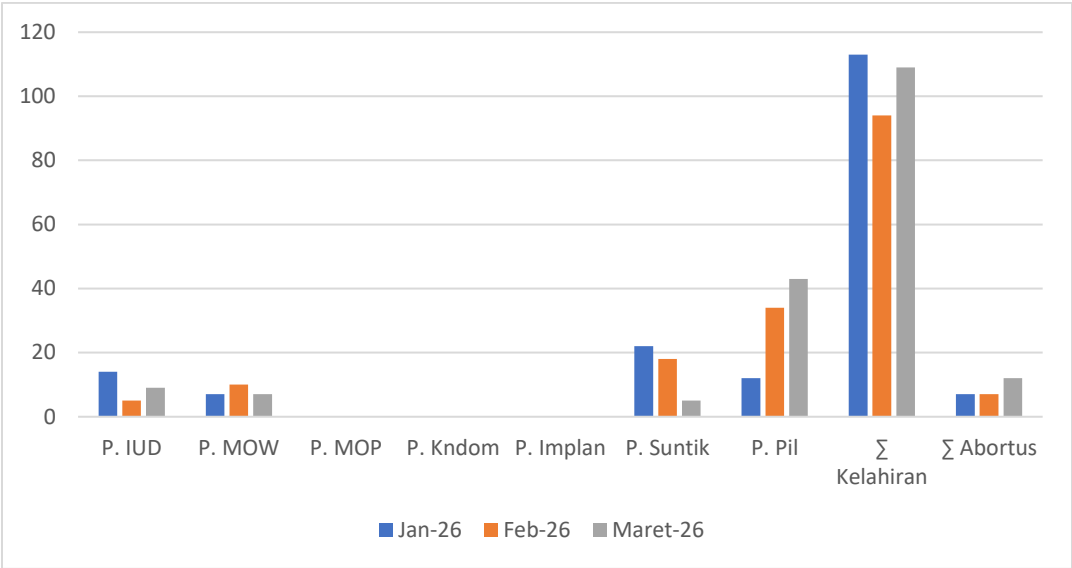
- 1) Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2) Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.5 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
3.5.1 Pelayanan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Maret 2026

Tabel 3.5.1 Pelayanan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponek RSPHM Maret 2026

No	Jenis	Jumlah Pasang		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	IUD	14	5	9
2	MOW	7	10	7
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	7	7	15
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	22	18	5
7	Pil	12	34	43
8	Σ Kelahiran	113	94	109
9	Σ Abortus	7	7	15

Grafik 3.5.1
Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Maret 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 akseptor, yang terdiri dari 4 akseptor IUD Nova T dan 5 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Maret 2026 sama dengan bulan Januari yaitu 7 pasien, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 10 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3) Tidak ada pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
- 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Maret 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 43 pengguna, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 34 pengguna, dan bulan Januari sebanyak 12 pengguna.
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Maret menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 pengguna, sedangkan bulan Februari 2026 sebanyak 18 pengguna, dan Januari 2026 sebanyak 22 pengguna,

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

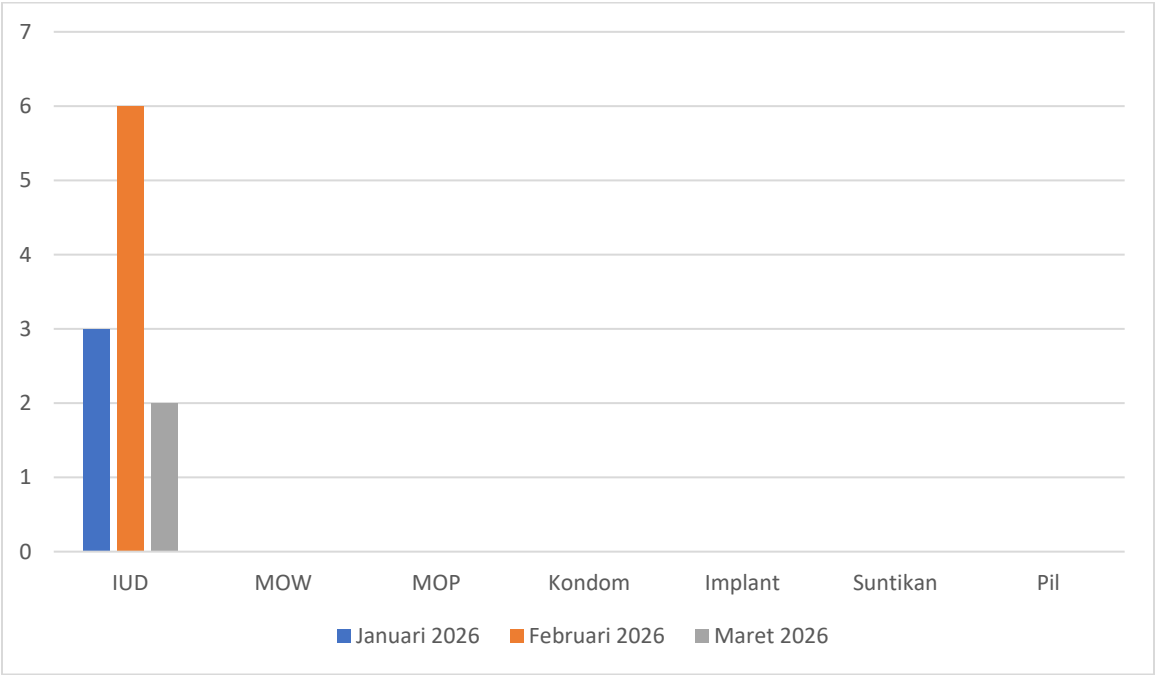
3.5.Pelayanan Pelepasan Keluarga Berencana (KB)

3.5.2 Pelayan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponек RSPHM Maret 2026

Tabel 3.5.2 Pelayan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponек RSPHM Maret 2026

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		Januari 2026	Februari 2026	Maret 2026
1	IUD	3	6	2
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik 3.5.2
Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis:

- 1. Pelepasan KB IUD pada bulan Maret 2026 menurun yaitu 2 Akseptor, sedangkan pada bulan Februari 2026 sebanyak 6 akseptor, dan bulan Januari 2026 sebanyak 3 akseptor,
- 2. Pelepasan KB Implan pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

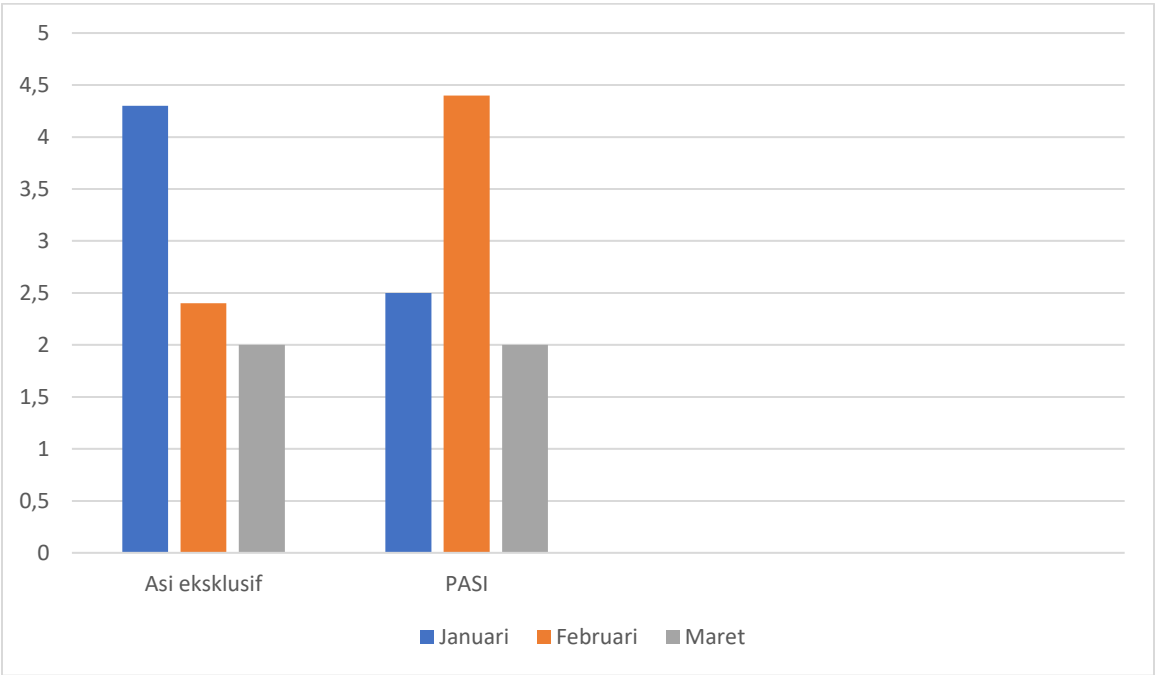
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3.10. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 3.3.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponpek RSPHM Maret 2026

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Asi eksklusif	105	96	103
2	PASI	0	0	0

Grafik 3.3.10
Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



- Analisis :**
- 1) Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Maret 2026 meningkat yaitu 103 bayi, dibandingkan bulan Februari 2026 sebanyak 96 bayi, sedangkan Januari 2026 sebanyak 105 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2) Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan Maret 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- 1) Edukasi ASI eksklusif sejak antenatal
 - 2) Melakukan konseling laktasi oleh dokter, bidan dan perawat

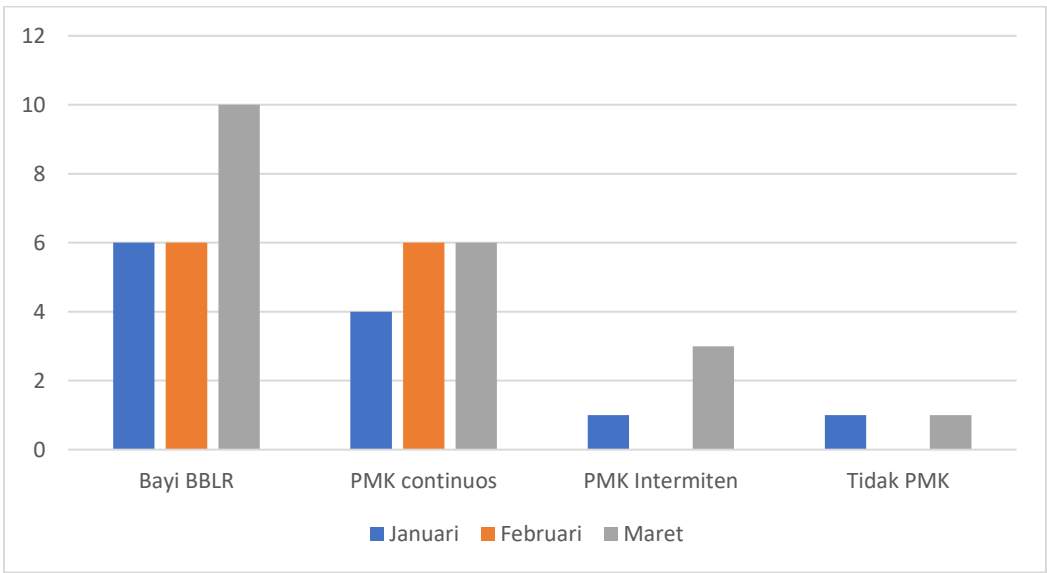
3.3.11. Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel 3.3.11 Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponsek RSPHM Bulan Maret 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Januari 2025	Bulan Februari 2025	Bulan Maret 2025
1	Bayi BBLR	6	6	10
2	PMK continuos	4	6	6
3	PMK Intermiten	1	0	3
4	Tidak PMK	1	0	1

Grafik 3.3.11

Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Maret 2026



- Analisis :
- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
 - 2) Ada 3 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Maret 2026, sedangkan pada bulan Februari tidak ada, dan Januari 2026 sebanyak 1. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
 - 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan Maret sama dengan Februari 2026 sebanyak 6 bayi, sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 4 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
 - 4) Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Maret dan Januari 2026, sedangkan pada bulan Februari tidak ada. Hal ini dikarenakan bayi dengan kelainan anenchepal dan bayi kemudian meninggal.

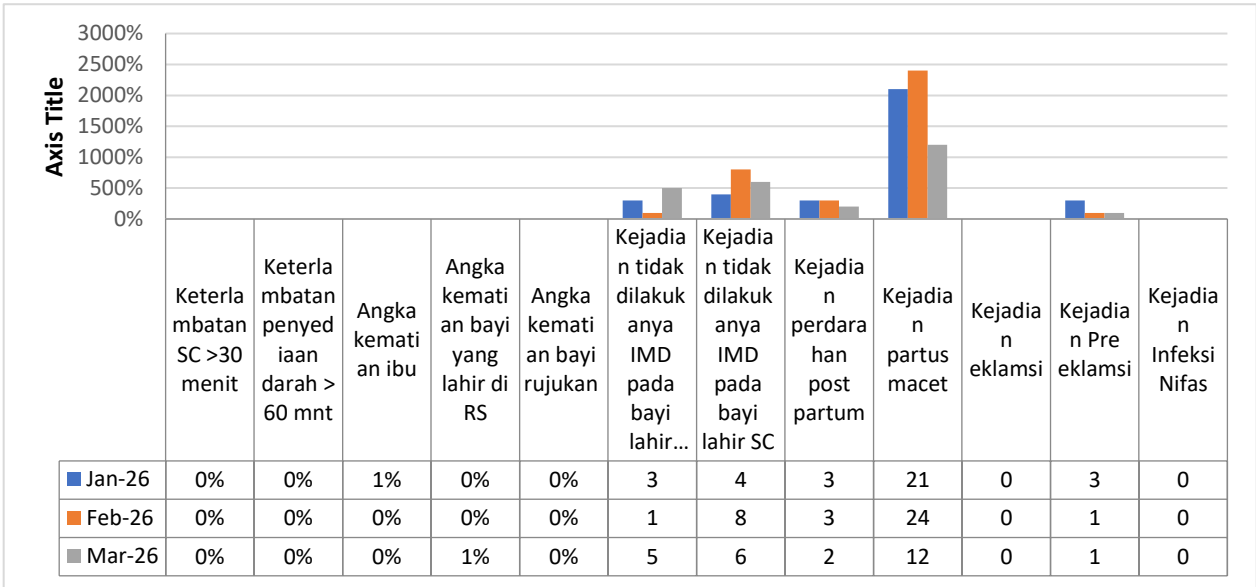
- Rencana dan Tindak Lanjut
- 1) Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku
 - 2) Memberikan edukasi kepada orang tua bayi untuk melakukan PMK

3.4 MUTU

Tabel 3.4 MUTU Ponek RSPHM Mutu bulan Maret 2026

No	Pengukuran Mutu	Standart	Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026
1	Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) >30 menit	0%	0%	0%	0%
2	Angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit)	<10%	0%	0%	0%
3	Angka kematian ibu	0%	0,9 %	0%	0%
4	Angka kematian bayi yang lahir di RS	0%	0%	0%	0,96%
5	Angka kematian bayi rujukan	0%	0%	0%	0%
6	Kejadian tidak dilakukanya IMD pada bayi lahir	0%	7	9	11
7	Kejadian perdarahan post partum	0	3	3	2
8	Kejadian partus macet	<10%	18,5%	31,3%	11,1%
9	Kejadian eklamsi	0	0	0	0
10	Kejadian Pre eklamsi	0	3	1	1
11	Kejadian Infeksi Nifas	0	0	0	0

Grafik 3.4
Mutu PONEK Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

- 1) Pada Mutu Angka kematian Ibu pada bulan Maret 2026 dan Februari 2025 sebanyak 0%, sedangkan pada bulan Januari 2026 sebanyak 0,9 %. Hal ini dikarenakan ada 1 kejadian kematian pada maternal pada bulan Januari 2026 yang disebabkan karena HPP.
- 2) Pada Mutu Angka kematian Bayi lahir di RS pada bulan Maret 2026 sebanyak 0,9 % sedangkan 2 bulan sebelumnya sebanyak 0 %, dan juga bayi rujukan sebanyak 0 %.
- 3) Pada mutu tidak dilakukannya Inisisasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir persalinan normal Pada bulan Maret 2026 sebanyak 5 bayi, sedangkan tidak dilakukannya IMD pada SC sebanyak 6 bayi.

4) Berikut alasan kenapa bayi tidak dilakukannya IMD pada bulan Februari 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
1	By Ny Zulia	NCB + BBLR	Infant warmer
2	By Ny Dayinta	BBLSR + Anenchepali	Cuvis
3	By Ny Putri Riskia	NCB + BBLR	Infant warmer
4	By Ny Alfiyah	NKB + BBLR	Infant warmer
5	By Ny Nur Habibahtur	NKB + BBLR	Infant warmer
SC			
1	By Ny Mella 1	NKB + BBLR + gemeli	Cuvis
2	By Ny Mella 2	NKB + BBLR + gemeli	Cuvis
3	By Ny Raquela	NKB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Maulidia	NKB + BBLR + RDS	Inkubator, CPEP
5	By Ny Bella	NCB + BBLR	Infant warmer
6	By Ny Ila Nur Janah	NCB + ibu Hepatitis B	Infant warmer

Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir dikarenakan bayi lahir dengan BBLR kurang bulan dan Asfiksia, sehingga bayi memerlukan tindakan segera untuk pemasangan alat bantu CPAP dan perawatan incubator. Oleh karena itu bayi tidak dilakukannya IMD. Perawat bayi melakukan IMD sesuai dengan syarat yang telah ditentukan kecuali pada bayi dengan kondisi asfiksia sedang-berat dan kelainan konginetal, pada TM III terjadi peningkatan pada kasus ini, bayi tidak di IMD yang disebabkan karena BBLR dan asfiksia sedang-berat yang membutuhkan perawatan incubator, C-pap dan oksigen.

- 5) Pada kasus pasien pre eklamsi pada bulan Maret dan Februari 2026 sebanyak 1 kasus. Unit terkait akan berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi.
- 6) Pada kasus Kejadian partus macet pada bulan Maret 2026 menurun, yaitu sebanyak 12 kasus, sedangkan bulan Februari 2026 sebanyak 24 kasus, dan bulan Januari 2026 sebanyak 21 kasus. Kejadian partus macet pada bulan Maret dikarenakan prolong fase laten, prolong fase aktif, dan kala 2 lama, sehingga pasien dilakukannya operasi SC.
- 7) Ada 2 Kejadian perdarahan post partum pada bulan Maret 2026, sedangkan bulan 2 bulan sebelumnya sebanyak 3 kasus. Kejadian perdarahan post partum pada bulan Maret 2026 disebabkan karena atonia uteri.
- 8) Tidak ada kejadian Infeksi nifas pada bulan Maret dan 2 bulan sebelumnya.

Rencana dan Tindak Lanjut

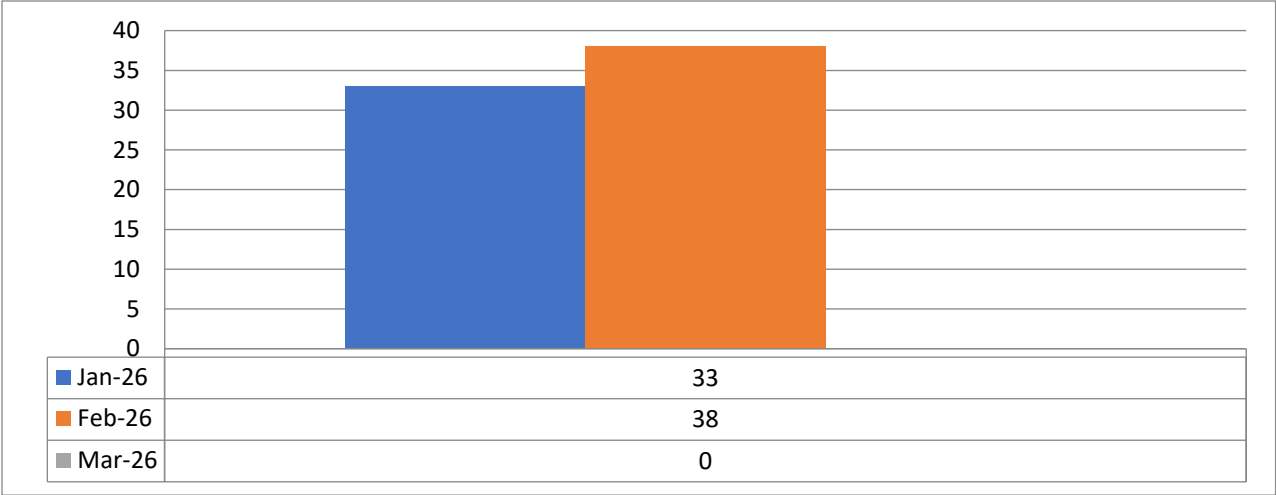
- 1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi
- 4) Memberikan Edukasi pada Ibu post Nifas terkait gizi yang dibutuhkan ibu Nifas, agar tidak terjadi lagi kasus infeksi pada Ibu nifas.
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah Kunci indikator mutu PONEK.
- 6) Koordinasi dengan Tim PMKP untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.5 Kelas Senam hamil
Tabel 3.5 Kelas senam hamil RSPHM Maret 2026

Pengembang an Pelayanan	Hasil kinerja	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
Senam Hamil	• Minggu ke 2 : Anggota : 30 peserta Hadir : 0 peserta. • Minggu ke 4 : Anggota : 30 peserta Hadir : 0 peserta .Target : 1 bulan 2 kali. Hasil : 2x/bulan = bumil	• Bulan maret tidak ada pelaksanaan senam hamil dikarenakan bulan Ramadhan • Rata-rata kehadiran bulan senam hamil 0 % Total persalinan 60% dari senam hamil yang diselenggarakan di PHM, dengan senam hamil ini dapat menambah citra RS yang lebih baik, menambah kunjungan dan semakin banyak orang yg menyukai RS Prima Husada Malang. • Jumlah peserta senam hamil masih belum mencapai target dengan jumlah peserta setiap datang target 30 peserta,.	• Berkolaborasi dengan asisten Poli Obgyn untuk mengedukasi pasien hamil uk diatas 22 minggu untuk mengikuti senam hamil. • KIE bahwa kelas senam teradapat Hypnopregnancy yang akan kontinyus dg hypno melahirkan. • Video Promosi senam hamil yang di tampilkan di IG RS dan di prima menyapa
Pengembang an Pelayanan	Hasil kinerja	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
Senam Hamil	• Minggu ke 2 : Anggota : 30 peserta Hadir : 0 peserta. • Minggu ke 4 : Anggota : 30 peserta Hadir : 0 peserta .Target : 1 bulan 2 kali. Hasil : 2x/bulan = bumil	• Pada bulan Maret untuk senam hamil sementara ditiadakan, dikarenakan bertepatan dengan bulan ramadhan. Total persalinan 65% dari senam hamil yang diselenggarakan di PHM, dengan senam hamil ini dapat menambah citra RS yang lebih baik, menambah kunjungan dan semakin banyak orang yg menyukai RS Prima Husada Malang. • Jumlah peserta senam hamil masih belum mencapai target dengan jumlah peserta setiap datang target 30 peserta,.	• Berkolaborasi dengan asisten Poli Obgyn untuk mengedukasi pasien hamil uk diatas 22 minggu untuk mengikuti senam hamil. • KIE bahwa kelas senam teradapat Hypnopregnancy yang akan kontinyus dg hypno melahirkan. • Video Promosi senam hamil yang di tampilkan di IG RS dan di prima menyapa

Grafik 3.5.1

Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2026



Analisis :

1. Peserta senam hamil pada bulan Maret 2026 yaitu 0 pasien, sedangkan pada bulan Februari 38 peserta, dan januari 33 peserta.
 2. Peserta senam hamil pada bulan Februari yang melahirkan di RS Prima Husada yaitu 65% pasien, sedangkan yang lain pasien melahirkan di faskes lain.
 3. Dari peserta senam hamil yang melahirkan, pasien mengatakan pada proses persalinan senam hamil dan hypnoterapi sangat membantu.
- ii.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan penjaringan ibu hamil usia kehamilan 22-24 minggu untuk melakukan senam hamil.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil di ruang tunggu poli untuk melakukan senam hamil
- 3) Berkolaborasi dengan PKRS membuat flayer promosi senam hamil yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn
- 4) Membuat video promosi senam hamil yang di putar di prima menyapa dan di upload di IG RS
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah peserta senam hamil.
- 6) Koordinasi dengan Tim PKRS untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.6 PKRS

Tabel 3.6 PKRS Ponpek RSPHM Bulan Maret 2025

Kegiatan	Target	Januari 2026		Februari 2026		Maret 2026	
Edukasi kelompok	4x/bl	1. Mnfaat jus kurma untuk meningkatkan produksi ASI 2. Persiapan senam hamil 3. Persiapan Kelahiran 4. Persiapan senam hamil		1. Persiapan persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Persiapan senam hamil 4. Manfaat senam hamil		1. Perawatan bayi baru lahir 2. Persiapan persalinan 3. Persiapan senam hamil 4. Manfaat senam hamil	
Edukasi individu	100%	1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC		1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC		1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB 7. Edukasi nyeri post SC	
Kegiatan	Target						
Pembinaan Jejaring	3x/tahun						

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Tabel 4. 1. Hasil Monitoring Ponek RSPHM Maret tahun 2026

No	Bulan	Kegiatan	Jumlah yang dipantau/ diobservasi	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
1	Maret	Kejadian tidak dilakukanya IMD pada bayi lahir	11 bayi	Bulan Maret terdapat 11 bayi yang tidak dilakukan IMD pada persalinan normal dan SC	Bayi dengan kondisi BBLR, Neonatal kurang bulan	1) Skin-to-Skin Contact setelah stabil, dilakukan di ruang NICU/Perinatologi jika memungkinkan. 2) Early Initiation of Expressed Breast Milk (EBM), Ibu dipandu memerah ASI dalam 1–2 jam pertama dan ASI diberikan melalui metode sesuai kondisi bayi 3) Metode Kangaroo Mother Care untuk bayi BBLR stabil.	Tim Ponek	
2		Kejadian perdarahan post partum	2 pasien	Terdapat 2 kasus perdarahan setelah melahirkan	Kontraksi tidak adekuat	1. Edukasi nutrisi pada saat kehamilan 2. Edukasi pasien untuk rutin melakukan ANC 3. Edukasi ibu hamil untuk melakukan senam hamil	Tim Ponek	

3		Kejadian partus macet	12 pasien	Terdapat kejadian partus macet 11,01%	His dan power pasien tidak adekuat	1. Edukasi pasien saat kemilan untuk melakukan senam hamil dan hypnoterapi 2. Edukasi pasien saat hamil untuk mencukupi kebutuhan nutrisi selama hamil	Tim Ponek	
4		Kejadian Pre eklamsi	1 pasien	Terdapat kejadian pre eklamsi 1 pasien	Tekana darah tinggi disertai hasil pemeriksaan protein urin +	1. Edukasi pasien kepatuhan kontrol kehamilan 2. Edukasi pasein untuk pola makan sehat dan istirahat yang cukup 3. Edukasi pasien untuk keputuhan minum obat	Tim Ponek	

4.2.Evaluasi

Tabel 4.2. 1 Hasil evaluasi Ponек Maret 2026

Bulan	Masalah yg dibahas	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
Maret	Pelayanan Imunisasi	Bayi baru lahir tidak mendapatkan imunisasi HB0	1.Vaksin Hb0 di puskesmas terbatas, bulan maret 2026 bayi baru lahir yang mendapatkan vaksin HB0 dari pemerintah yaitu 23 pasien / 22,12%, bayi yang mendapatkan imunisasi Engerix Junior yaiu (vasksin Hb0 swasta) yaitu 31 bayi, sedangkan jumlah kelahiran bulan Februari yaitu sebanyak 104 bayi. 2.Pasien yang melahirkan di RS Prima Husada tidak hanya dari wilayah singosari melainkan dari luar wilayah Puskesmas singosari	1. Koordinasi dengan Puskesmas Singosari untuk pelaporan vaksin 2. Pengadaan vaksin Engerix Junior	Neonatologi	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	IUD pasca lahir	1.Pemasangan IUD pasca lahir 10,5% dikarenakan pemasangan IUD berbayar jika dipasang dokter, dan pasien menginginkan KB selain IUD	1. Melakukan edukasi pasien inpartu, rencana SC, pasien abortus	Maternitas	

			2. Pasien memilih KB setelah nifas	2. Edukasi pasien dan penunggu di ruang tunggu poli kandungan oleh PJ KBRS 3. Membuat flayer KB yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn		
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

Tabel 4.2.2 Hasil Rekapitulasi Supervisi Bulan Maret 2026

No.	Komponen yang dinilai	Standar	Dilakukan		Temuan	Tindak Lanjut
			Ya	Tidak		
1	Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan PONEK 24 jam.	PONEK 1 EP 1	√	-	Sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
2	Terdapat Tim PONEK yang ditetapkan oleh rumah sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.	PONEK 1 EP 2	√	-	SK Tim Ponek sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
3	Terdapat program kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit maksud dan tujuan.	PONEK 1 EP 3	√	-	Sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
4	Terdapat bukti pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit	PONEK 1 EP 4	√		Bukti laporan tentang pelaksanaan program PONEK pada Laporan Triwulan PONEK dan sudah di Disposisi Direktur	Melakukan monitoring dan evaluasi
5	Program Ponek Rumah Sakit dipantau dan di evaluasi secara rutin	PONEK 1 EP 5	√		Bukti tentang program PONEK Rumah Sakit dipantau dan dievaluasi secara rutin pada Laporan Triwulan PONEK. pelaksanaan pemberian materi edukasi ke pasien : 1. Imunisasi : Hasil supervisi pelaksanaan Imunisasi HB0 49% dari 109 pasien bayi baru lahir. 2. KB : Hasil supervisi pelaksanaan KB pasca persalinan 10,9 % dari 109 pasien melahirkan, sedangkan pelaksanaan KB pasca keguguran 100% 3. IMD : hasil supervisi pelaksanaan IMD 100% dari 99 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien danagnbayi sehat.	Melakukan monitoring dan evaluasi

				4. Asi Eksklusif; hasil supervisi 100 % dari 109 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 5. PMK : hasil supervisi 100% dari 9 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 6. Perawatan BBL : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan BBL 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 7. Makan & minum ibu menyusui : hasil supervisi pelaksanaan edukasi makan minum ibu menyusui 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 8. Cek ASI : hasil supervisi pelaksanaan cek ASI 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 9. Rawat gabung: hasil supervisi pelaksanaan rawat gabung 100% dari pasien yang di observasi 101 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 10. Menyusui Bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi menyusi bayi 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 11. Perawatan Payudara : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 12. Personal Hygine : hasil supervisi pelaksanaan edukasi personal Hygine 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 13. Perawatan luka post sc+post partum : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan luka post op sc dan post partum 100% dari pasien yang di observasi 80 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 14. Pijat laktasi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi pijat laktasi 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien	
--	--	--	--	---	--

					Materi edukasi Tersedia elektronik dan fisik dilengkapi dengan barcode 15. Menjemur bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi menjemur bayi 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 16. Perawatan tali pusat : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 17. Memandikan bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi memandikan bayi 100% dari pasien yang di observasi 109 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien. Berikut media edukasi promosi kesehatan https://sites.google.com/view/rsprimahusada/leaflet	
6	Rumah sakit menetapkan program pembinaan jejaring rujukan rumah sakit.	Ponek 1.1 EP 1	√			
7	Rumah sakit melakukan pembinaan terhadap jejaring secara berkala.	Ponek 1.1 EP 2	√		Pembinaan jejaring dilakukan belum dilaksanakan	Melakukan monitoring dan evaluasi
8	Telah dilakukan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan	Ponek 1.1 EP 3	√		Rujukan masuk bulan Maret 9 pasien saat merujuk sudah dilakukan penatalaksanaan awal rujukan, perujuk sudah konfirmasi ke RS	monitoring dan evaluasi

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan Ponek bulan Maret 2026 disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang . Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Ketua Tim PONEK


dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 3 April 2026
Direktur Rumah Sakit
Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes